



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : تهاني مصطفى سليمان السيد

المحافظة : الفيوم الحي / المدينة : طاميه

رقم البطاقة : 28502202302409 رقم التليفون : 01029236114

العنوان : قصر رشوان-

تاريخ تسجيل الإستمارة : 20-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 20-02-1985 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: تهاى مصطفى سليمان السيد National ID: 28502202302409	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحرق الشخصية

تهاني
مصطفى سليمان السيد
قصر رشوان
مركز طامية - الفيوم

١٩٨٥/٠٣

٢٨٥.٠٢٢.٢٣.٠٢٤.٩

KM0166858



٢٠٢٤/٠٣ ٢٨٥.٠٢٢.٢٣.٠٢٤.٩



فلاحه
انثى
مسلمة
سالم عني عبدالسميع صانع
البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٣/٠٤





Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



A-Patient ID#

1- Name: كوشى محمد بنى واليمان النجدي

Sex

MDT form

2- Medical numbers

03132298

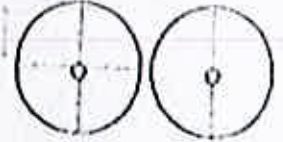
Old Med

Old Med

1021-2023

3-10 numbers 28502202302400

Patient Age: 39 Y



Family history

Family history
+ve

Phone

Phone

01060176047
01029236114

BRE

g 2c

REASON OF HOT

REASON OF HOT
POST OPERATIVE

marital status

Marital status
Married

HRB Score

HRB Score

GROUP

GROUP

Date of HOT

Date of HOT

2023-11-11

to morbidity

to morbidity
free

Menopausal
status

Menopausal status
Perimenopausal

Breast Imaging:

Mets Workup:
CT CAP/FREE
bone scan free

BX

10C

EXCISE

ER

8/8

EXCISE

PR

8/8

EXCISE

Her 2 Neu

Her 2 Neu
EXCISE

91911

EXCISE

X167

40

Y

4d

N

1

M

0

Sonomammography

LY LABC MULTICENTRIC LY 10 OCLOCK 5+. CM REACH TO NIPPLE
WITH IPISILATERAL PATHOLOGICAL AXILLARY LN

PATIENT HISTORY

pt received 4 DD AC + 12 weeks taxol

LY MRM:

YPTO YPN1

free deep margins&NAC

LN 1/23WXTOUT EXTRA Capsular Infiltration

partial pathological response

RECOMMENDATION

FOR PORT, ZOLADEX/AT 5 YS AND CONSIDER EXTENDED
PROLTA/GMN FOR 3 YS AFTER DENTAL

MEDICAL ONCOLOGY

Medical Oncology
2023/11/11

RADIOLOGY

Radiology
2023/11/11

Patient Name : الأستاذ / نهالي مصطفى سليمان السيد
Patient No. : 28502202302409
Path No. : 3409/23
Sex : Female
Age : 38 Y
Referring Doc :

Request No. : 13002815
Request Date : 07/10/2023
Verification Date : 22/10/2023
Financial Category : ارقام دار السلام - مبلره
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer (post NACT) .

Nature of the specimen: Left MRM

Gross Examination:

- Procedure: Left MRM
- measured 25x25x6 cm with covering skin ellipse measured 25x18 cm & attached axilla 10x9 cm .
- Tumor extent : A greyish white tumour bed site
- Size: 4x3 cm .
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly .
- Distance from margins: 3cm away from deep margin .
- Lymph nodes number and size: 23 L.Ns up to 2x1 cm .
- Rest of breast showed thickened grayish white tissue in dilated ducts.

Microscopic examination:

- Histological type: No residual viable tumor tissue detected
- Ductal carcinoma in situ: No
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Positive one L.N (1/23) with no extracapsular extension.
- Resection Margins: Free deep margin.
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response.

Diagnosis:

Left MRM (post NACT) :

- Total burned out tumour (No residual viable tumor tissue detected).
- Free deep margin.
- Free nipple and areola

Verified by :

DR.Menna Nabil

Printing Date : 24/10/2023 11:25:46

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



شراة رقم (4) - الدور الأول - المبنى رقم (987) - مبنى التوليد - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987 - Nda Corulche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذ / د. هادي مصطفى مكي
Patient No. : 28502202302409
In No. : 586/2023
Sex : Female
Age : 38 Y
Referring Doc. :

Request No. : 13005552
Request Date : 27/02/2023
Verification Date : 19/03/2023
Financial Category : اورام دار السلام - مبالغه
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical data:
Breast mass.

Site of specimen:
Tru cut biopsy, collected at 26/2/2023, 10:30 am

Gross Examination:
Multiple grayish white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.
Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, IHC clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:
Histological type: Invasive duct carcinoma.
Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+3+3) Grade III
IHCIS: not detected
Angiolymphatic invasion: Couldn't be detected in the received biopsy
IHC (Positive control showed appropriate reactivity):
ER: Strong nuclear reaction in 90 % of tumor cells (Allred score 8/8).
PR: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 8/8).
Her2: No membrane reaction in the tumor cells (score 0).
Ki67: 40% nuclear reaction of tumor cells.

DIAGNOSIS

Tru cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade III.
IHC:
ER: Positive (score 8/8).

Verified by :
DR. Menna Nabil

Reporting Date : 19/03/2023 11:22:13

Page 1 of 3

Printed By : DR. Menna Nabil

Patient Name: الأستاذة / نهدي مصطفى مبارك السيد
Patient No.: 28502202302409
Path No.: 586/2023
Sex: Female
Age: 38 Y
Referring Doc.:

Request No.: 13005552
Request Date: 27/02/2023
Verification Date: 19/03/2023
Financial Category: اورام خارج العظام - مبدئية
Department: Out Patient

Registered by: marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

PR: Positive (score 8/8).
Her2: Negative (score 0).
Ki67: Positive in 40% of tumor cells

Scoring system: *ER, PR*

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

Scoring system: *Her2*

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within ? 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within ? 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Iman Gouda
Dr. Hebatallah Mostafa

Verified by:
DR. Monna Nabil

Printing Date : 19/03/2023 11:22:13

Page 2 of 3

Printed By : DR. Monna Nabil

Report generated by the Pathology Lab, Ministry of Health, Egypt.
For more information, please contact the Pathology Lab, Ministry of Health, Egypt.



Exam Information:

<u>Patient Name:</u> D Mustafa	<u>Date of birth:</u> 20/02/1985
<u>Arabic Name:</u> نهالى مصطفى	<u>Patient Gender:</u> F
<u>Patient RIS ID:</u> 332179	<u>Exam Date:</u> 22/07/2023
<u>Patient HIS ID:</u> 123014436	<u>Approved by:</u>
<u>Written by:</u>	Dr. Hoda Fathy
Dr. Hoda Fathy	

^{99m}Tc MDP Bone Scan Report (22/07/2023)

• blood pool Anterior and Posterior Images for 1000k count followed by Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of ^{99m}Tc MDP Revealed:

- No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
- Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
- Both kidneys are visualized.

Conclusion:

- No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Dr/Mayadah Ashraf
Nahla Mamoun, MSc

Much Obligated

MUSTAFA SULAIMAN, D Patient ID: 123014436 DOB: 20-Feb-1985 Date: 05-Sep-2026

Patient Lastname: Mustafa Sulaiman

Patient Firstname: D

HIS Patient ID: 123014436

RIS Patient ID: 332179

Date of Birth: 20/02/1985

Procedure: 15660, MRI Hip Joints with Contrast

Clinical Comment:

===== REPORT TEXT =====

Mri of both hips and upper femur :

" Normal bone marrow signal

" Normal hip joint

" No sizable soft tissue masses

Dr manal Refaat

===== REPORT TEXT END =====

Approved By: MANAL M